

## UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO

Facultad de Ciencias de la Computación · Carrera de Software

## GUÍA DE PRÁCTICA EN CLASE — PARALELO B

Priorización de requisitos con MoSCoW y simulación de negociación entre roles

(cliente · analista · desarrollador)

|                          |                                                                                                                                                                                |          |               |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|
| Asignatura               | Ingeniería de Requisitos (ISR-401)                                                                                                                                             |          |               |
| Unidad / Tema            | Unidad 2 — Tema 6: Análisis de Requisitos (Subtemas 6.1 y 6.4)                                                                                                                 |          |               |
| Resultado de aprendizaje | Aplica técnicas de elicitación y análisis de requisitos para identificar, clasificar y priorizar requisitos funcionales y no funcionales, asegurando completitud y coherencia. |          |               |
| Modalidad                | Grupal (3 estudiantes)                                                                                                                                                         | Duración | 100 min       |
| Tipo                     | Práctica en clase con simulación de negociación entre roles                                                                                                                    |          |               |
| Paralelo / Periodo       | B                                                                                                                                                                              | Período  | 2026–2027 PPA |
| Puntaje                  | 10 puntos (rúbrica analítica incluida en este documento)                                                                                                                       |          |               |

**Indicación para el equipo Paralelo B.** Esta guía conserva exactamente la misma estructura pedagógica y rúbrica que la del Paralelo A, pero usa un **caso de estudio diferente** (telemedicina) con su propio *backlog*, dependencias y conflictos. **No basta con adaptar la solución del Paralelo A:** las decisiones aquí deben justificarse con la información de este caso.

## 1. Objetivo de la práctica

Al finalizar la práctica, el estudiante será capaz de:

- **Aplicar** la técnica MoSCoW (Must, Should, Could, Won't) para priorizar un conjunto de requisitos bajo una restricción real de capacidad. *(Bloom: Aplicar)*
- **Analizar** las causas y los tipos de conflicto que surgen entre stakeholders con intereses divergentes. *(Bloom: Analizar)*
- **Negociar** una solución *win-win* que respete las dependencias técnicas y las restricciones del proyecto. *(Bloom: Evaluar)*
- **Construir** un acuerdo documentado (acta de negociación) que integre la votación ponderada como criterio de desempate. *(Bloom: Crear)*

## 2. Marco de referencia

Esta práctica integra dos conceptos del Tema 6:

- **Priorización (6.1):** MoSCoW como técnica de categorización y la votación ponderada como técnica de desempate cuantitativa. La prioridad es un atributo de requisito según IEEE/ISO/IEC/IEEE 29148:2018.
- **Negociación (6.4):** causas de conflicto (intereses, datos, estructura), tipos de conflicto y estrategias de resolución, con énfasis en el enfoque *win-win* (Pohl, 2010; IREB CPRE). El analista actúa como mediador del proceso.

## 3. Conformación de los equipos y roles

Cada equipo se conforma con **tres integrantes**, uno por rol. La información de cada rol es **asimétrica**: cada participante conoce datos que los demás no tienen, tal como ocurre en un proyecto real. La negociación consiste, en parte, en *revelar* y *conciliar* esa información.

- **Rol 1 — Cliente / patrocinadora del negocio** (dueña de la clínica MediCita).
- **Rol 2 — Analista de requisitos** (mediador del proceso; vela por la calidad y la coherencia).
- **Rol 3 — Desarrollador líder** (responsable de la viabilidad técnica y del esfuerzo).

Si el equipo tiene 4 integrantes, el cuarto asume el rol de **observador-relator**: no negocia, pero registra los conflictos detectados y completa el Anexo C.

#### 4. Caso de estudio: “MediCita”

##### Contexto del negocio

**MediCita** es una clínica privada de tamaño mediano que ofrece consultas en medicina general y especialidades. Hoy las citas se agendan por teléfono, los pagos se cobran en caja y las recetas se entregan en papel. La dueña, la Dra. Patricia Mendoza, ha decidido invertir en una **plataforma web y móvil** que profesionalice la operación y le permita competir con una clínica más grande que está por entrar al mercado con su propia plataforma.

El equipo de desarrollo dispone de una capacidad limitada para la **primera versión (Release 1)** del producto. No todos los requisitos deseados caben en esa primera entrega: hay que decidir *qué entra, qué espera y qué queda fuera por ahora*. Para ello, los tres roles deben reunirse, priorizar y negociar.

**Restricción de capacidad (dato compartido por todo el equipo):** el Release 1 tiene una capacidad de desarrollo de **30 puntos de esfuerzo**. La suma del esfuerzo de los requisitos marcados como **Must no puede exceder 30 puntos**. Se recomienda dejar un margen de holgura (idealmente que los *Must* no superen  $\approx 24$  puntos) para los *Should* y para imprevistos.

##### Backlog de requisitos candidatos

El esfuerzo está expresado en puntos relativos estimados por el equipo técnico. Observe la columna “**Depende de**”: un requisito no puede entrar al Release sin sus dependencias.

| ID     | Descripción del requisito                                                                                                | Tipo | Esf. | Depende de |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------------|
| RF-01  | El sistema permite el registro de pacientes con correo y contraseña.                                                     | RF   | 3    | —          |
| RF-02  | El paciente reserva citas en línea eligiendo médico, fecha y hora.                                                       | RF   | 5    | RF-08      |
| RF-03  | El paciente realiza la consulta por videollamada en vivo dentro de la plataforma.                                        | RF   | 8    | —          |
| RF-04  | El sistema procesa pagos en línea con tarjeta mediante una pasarela externa.                                             | RF   | 8    | NFR-01     |
| RF-05  | El médico emite recetas electrónicas con firma digital.                                                                  | RF   | 5    | NFR-01     |
| RF-06  | El médico consulta el historial clínico digital del paciente durante la cita.                                            | RF   | 5    | —          |
| RF-07  | El sistema envía recordatorios automáticos de cita (push / correo).                                                      | RF   | 3    | —          |
| RF-08  | El panel del médico permite gestionar agenda y pacientes.                                                                | RF   | 5    | —          |
| RF-09  | El paciente califica y reseña al médico al finalizar la consulta.                                                        | RF   | 3    | —          |
| RF-10  | Chat asíncrono médico–paciente entre citas.                                                                              | RF   | 5    | —          |
| RF-11  | El sistema genera facturación electrónica del cobro.                                                                     | RF   | 5    | REST-01    |
| RF-12  | El sistema produce reportes de actividad para la dirección de la clínica.                                                | RF   | 5    | RF-08      |
| NFR-01 | Los datos clínicos y de pago se almacenan cifrados conforme a la normativa de protección de datos personales y de salud. | NFR  | 5    | —          |

| ID      | Descripción del requisito                                                                            | Tipo   | Esf. | Depende de |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|------------|
| NFR-02  | La aplicación es utilizable por pacientes mayores de 60 años (mín. 4 toques para reservar una cita). | NFR    | 3    | —          |
| NFR-03  | La videollamada mantiene latencia $< 250$ ms en el 95 % de las sesiones.                             | NFR    | 3    | —          |
| NFR-04  | La plataforma garantiza disponibilidad del 99,5 % mensual.                                           | NFR    | 5    | —          |
| REST-01 | El sistema debe integrarse con el sistema de la farmacia asociada para entrega de recetas.           | Restr. | —    | —          |

**Pista de coherencia (para todos):** dos cuidados que la rúbrica penaliza si se incumplen: **(1)** si un requisito es *Must*, sus dependencias también deben ser al menos *Must*; **(2)** un requisito que procese pagos o datos clínicos no es coherente sin su requisito de cifrado (NFR-01).

## 5. Tarjetas de rol (información asimétrica)

*Indicación para el docente: recorte y entregue a cada estudiante **solo** su tarjeta. Los demás roles no deben conocer su contenido hasta la negociación.*

### ROL 1 — CLIENTE / PATROCINADORA (Dra. Patricia Mendoza, dueña de MediCita)

**Tus objetivos:** lanzar pronto y captar pacientes antes que la competencia. Tú decides la inversión.

**Información que solo tú conoces:**

- Una clínica más grande lanzará su propia plataforma en **aproximadamente 6 semanas**; necesitas salir **antes**.
- Tus pacientes piden, sobre todo, dos cosas: **atenderse desde casa por videollamada y pagar por adelantado con tarjeta**.
- Crees que las **calificaciones y reseñas (RF-09)** y los **reportes de actividad (RF-12)** te ayudarán a fidelizar y a tomar decisiones.
- Tu presupuesto es ajustado: prefieres una primera versión **pequeña pero atractiva**.

**Tu tendencia natural:** marcar como “Must” muchas funciones de cara al paciente. *Cuidado: no todo cabe.*

### ROL 2 — ANALISTA DE REQUISITOS (mediador del proceso)

**Tu rol:** no defiendes intereses propios; velas por la **calidad, la completitud y la coherencia**, y **medias** entre cliente y desarrollador buscando un acuerdo *win-win*.

**Información que solo tú conoces:**

- Por **normativa de protección de datos personales y de salud**, manejar datos clínicos o pagos **obliga** a tener el requisito de **cifrado (NFR-01)**: no es opcional si se acepta cualquier requisito con datos sensibles (RF-04, RF-05, RF-06).
- Por normativa de **receta electrónica**, RF-05 requiere firma digital del médico (cubierta dentro de NFR-01); sin eso, las recetas deben seguir en papel.
- La **usabilidad (NFR-02)** determina la adopción: gran parte de los pacientes son adultos mayores; una app difícil de usar fracasa aunque tenga muchas funciones.
- Tu deber es **detectar dependencias y conflictos**, y dejar todo **documentado** en el acta.

**Tu herramienta clave:** cuando dos requisitos compiten por la misma capacidad, propón una **votación ponderada** para desempatar (Anexo B).

### ROL 3 — DESARROLLADOR LÍDER (responsable técnico)

**Tu objetivo:** entregar algo **funcional, estable y mantenible** dentro de la capacidad de 30 puntos. Defiendes la viabilidad técnica.

**Información que solo tú conoces (riesgos técnicos):**

- **RF-03 (videollamada)** y **RF-04 (pago en línea)** dependen de **servicios externos** y son los de **mayor riesgo**: si fallan, retrasan todo el Release.
- **RF-02 no funciona sin RF-08** (no se reservan citas en línea si el médico aún no tiene panel de agenda).
- **RF-12 no funciona sin RF-08** (los reportes necesitan los datos del panel).
- **REST-01** (integración con la farmacia asociada) **aún no está disponible**; mientras no lo esté, **RF-11 no puede entrar**.
- Recomendas **no** llenar los 30 puntos con “Must”: deja holgura para pruebas e imprevistos.

**Tu tendencia natural:** empujar funciones complejas a “Could” o “Won’t”. *Cuidado: el negocio también debe ganar.*

## 6. Procedimiento (100 minutos)

| Fase | Tiempo | Actividad                                                                                                                                                                                          |
|------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | 10 min | Lectura del caso, reparto de tarjetas y asignación de roles dentro del equipo.                                                                                                                     |
| 2    | 15 min | <b>Priorización individual por rol.</b> Cada participante completa su columna MoSCoW en el Anexo A según su tarjeta, <i>sin</i> ver las de los demás.                                              |
| 3    | 30 min | <b>Negociación.</b> Los roles exponen sus prioridades, revelan su información, identifican conflictos y buscan un acuerdo <i>win-win</i> que respete la capacidad de 30 puntos y las dependencias. |
| 4    | 15 min | <b>Desempate por votación ponderada</b> (Anexo B) para los requisitos “Should” que compiten por la capacidad restante.                                                                             |
| 5    | 15 min | <b>Cierre del acuerdo.</b> Completan el consenso MoSCoW final (Anexo A) y el acta de negociación (Anexo C). Firman los tres roles.                                                                 |
| 6    | 15 min | <b>Puesta en común</b> (plenaria): dos equipos presentan su Release 1 y justifican un conflicto que resolvieron.                                                                                   |

**Anexo A — Plantilla de priorización MoSCoW**

Andrade Jose, Gilces Jose,

**Equipo:** Herrera Gilmar ..... **Paralelo:** B **Fecha:** 3 de Junio de 2026 .....

Escriba **M** (Must), **S** (Should), **C** (Could) o **W** (Won't) en cada celda. Las columnas *Cliente* y *Desarrollador* son la priorización *individual* (Fase 2); la columna *Consenso* es el resultado negociado (Fase 5).

| ID                                                     | Requisito (resumen)           | Esf.                      | Cliente | Desarroll. | Consenso |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|---------|------------|----------|
| RF-01                                                  | Registro de pacientes         | 3                         | M       | M          | M        |
| RF-02                                                  | Reserva de citas en línea     | 5                         | M       | S          | M        |
| RF-03                                                  | Consulta por videollamada     | 8                         | M       | C          | M        |
| RF-04                                                  | Pago en línea (tarjeta)       | 8                         | M       | W          | W        |
| RF-05                                                  | Receta electrónica firmada    | 5                         | M       | W          | W        |
| RF-06                                                  | Historial clínico digital     | 5                         | S       | C          | C        |
| RF-07                                                  | Recordatorios de cita         | 3                         | M       | S          | S        |
| RF-08                                                  | Panel del médico (agenda)     | 5                         | S       | M          | M        |
| RF-09                                                  | Calificación del médico       | 3                         | M       | C          | S        |
| RF-10                                                  | Chat asíncrono                | 5                         | S       | W          | W        |
| RF-11                                                  | Facturación electrónica       | 5                         | S       | W          | W        |
| RF-12                                                  | Reportes de actividad         | 5                         | M       | C          | C        |
| NFR-01                                                 | Cifrado / protección de datos | 5                         | S       | M          | M        |
| NFR-02                                                 | Usabilidad (adultos mayores)  | 3                         | C       | M          | M        |
| NFR-03                                                 | Latencia videollamada <250 ms | 3                         | M       | S          | S        |
| NFR-04                                                 | Disponibilidad 99,5 %         | 5                         | S       | S          | S        |
| <b>Suma de esfuerzo de los <i>Must</i> (consenso):</b> |                               | pts (debe ser $\leq 30$ ) |         |            |          |

**La nota “analista” no se prioriza por separado:** el analista no marca su propia columna porque no defiende intereses; su trabajo se evalúa por la calidad de la mediación y del acta. (El analista *sí* verifica que la columna “Consenso” respete capacidad y dependencias.)

## Anexo B — Votación ponderada (desempate)

Use esta tabla *solo* para los requisitos que el equipo dejó en disputa (“Should” que compiten por la capacidad restante). Califique cada criterio de **1 a 5** y multiplique por su peso. El de mayor puntaje total entra primero.

**Criterios y pesos:** Valor de negocio (0,40) · Bajo esfuerzo (0,25) · Bajo riesgo técnico (0,20) · Urgencia/dependencia satisfecha (0,15).

| ID     | Requisito en disputa                                                | V. negocio<br>(×0,40) | Bajo esf.<br>(×0,25) | Bajo riesgo<br>(×0,20) | Urgencia<br>(×0,15) |
|--------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|---------------------|
| RF-07  | El sistema envía recordatorios automáticos de citas (push/correo)   | 1.6                   | 1.25                 | 1.0                    | 0.6                 |
| RF-09  | El paciente califica y reseña al médico al finalizar la consulta    | 1.2                   | 1.25                 | 0.8                    | 0.3                 |
| NFR-03 | La videollamada mantiene latencia <250 ms en el 95% de las sesiones | 2.0                   | 1.00                 | 0.4                    | 0.75                |
| NFR-04 | La plataforma garantiza disponibilidad del 99,5% mensual            | 1.6                   | 0.75                 | 0.8                    | 0.6                 |

| ID     | Puntaje total ponderado (suma de los cuatro productos) | Orden |
|--------|--------------------------------------------------------|-------|
| RF-07  | $1.6 + 1.25 + 1 + 0.6 = 4.45$                          | 1°    |
| RF-09  | $1.2 + 1.25 + 0.8 + 0.3 = 3.55$                        | 4°    |
| NFR-03 | $2.0 + 1.0 + 0.4 + 0.75 = 4.15$                        | 2°    |
| NFR-04 | $1.6 + 0.75 + 0.8 + 0.6 = 3.75$                        | 3°    |

## Anexo C — Acta de negociación

### C.1 Conflictos identificados

Registre al menos **dos** conflictos surgidos durante la negociación.

| N° | Descripción del conflicto                                        | Tipo / causa                        | Roles implicados                 |
|----|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| 1  | El cliente quiere incluir el RF-04 y RF-03 simultáneamente       | Conflicto de intereses y de alcance | Cliente y Desarrollador Líder    |
| 2  | El cliente no le interesa la usabilidad para los adultos mayores | Conflicto de votación y prioridades | Cliente y Analista de requisitos |

### C.2 Resolución win-win

Explique, para **cada** conflicto, qué acuerdo alcanzaron y por qué *ambas partes ganan* (no por imposición). Indique qué se cedió y qué se obtuvo a cambio.

#### Conflicto 1:

El cliente quiere incluir Videollamadas RF-03 y Pagos en Línea RF-04, cuando existe la incapacidad técnica límite de 30 puntos. Se acordó priorizar la Videollamada RF-03 como el factor diferenciador clave contra la competencia para el Release 1, por lo que el cliente cedió posponiendo el Pago en Línea RF-04 para el Release 2, cobrando temporalmente en caja. El desarrollador aceptó mitigar el riesgo técnico concentrándose en una sola función compleja al mismo tiempo.

#### Conflicto 2:

El cliente subestima la Usabilidad para los Adultos Mayores NFR-02, mientras que el Analista exige su obligatoriedad. Finalmente, el cliente aceptó elevar NFR-02 a Must después de entender que muchos de sus clientes son adultos mayores y podría fracasar la aplicación. A cambio, se obtuvo el compromiso del desarrollador de diseñar interfaces simplificadas que asegurarían el éxito de la app.

### C.3 Verificación del analista

Marque con ✓ cuando se cumpla.

- ☒ La suma del esfuerzo de los *Must* es  $\leq 30$  puntos.
- ☒ Todo requisito *Must* tiene sus dependencias marcadas como *Must*.
- ☒ Si se aceptó pago en línea (RF-04), receta electrónica (RF-05) o historial clínico (RF-06), el cifrado (NFR-01) es *Must*.
- ☒ RF-11 (facturación) no es *Must* mientras REST-01 no esté disponible.
- ☒ Cada categoría (M/S/C/W) tiene al menos un requisito (la lista no es solo “Must”).

### C.4 Reflexión final (mínimo 120 palabras)

¿Qué estrategia de resolución de conflictos predominó y por qué? ¿Qué habría pasado si la dueña de la clínica hubiera impuesto todas sus prioridades sin negociar?

---



---



---



---

Firma — Cliente

Firma — Analista

Firma — Desarrollador

## Rúbrica de evaluación (10 puntos)

### Requisitos previos de admisión (gatekeepers)

Si **cualquiera** de los siguientes no se cumple, el trabajo recibe la **calificación mínima de 1,0** y **no se evalúan** los criterios siguientes:

- Se entrega el **acta firmada** por los tres roles (Anexo C completo).
- La columna **Consenso** del Anexo A está **completa** (los 16 requisitos clasificados).
- La suma del esfuerzo de los *Must* **respeto la capacidad** ( $\leq 30$  puntos).
- Cada integrante **participó en su rol** (verificado por el docente durante la sesión).

### Criterios calificados

|              | Criterio (Bloom)                         | Indicador de logro pleno                                                                                               | Pts         |
|--------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| C1           | Priorización MoSCoW individual (Aplicar) | Cada rol prioriza de forma coherente con su tarjeta; usa correctamente las cuatro categorías; clasifica bien RF / NFR. | 2,0         |
| C2           | Análisis de conflictos (Analizar)        | Identifica $\geq 2$ conflictos reales del caso, con su tipo y causa correctamente nombrados (no genéricos).            | 2,0         |
| C3           | Negociación win-win (Evaluar)            | La resolución muestra cesiones recíprocas justificadas; ambas partes obtienen valor; no hay imposición.                | 2,5         |
| C4           | Votación ponderada (Aplicar)             | Aplica criterios y pesos correctamente; el cálculo del desempate es correcto y consistente con el consenso.            | 1,5         |
| C5           | Consenso coherente (Evaluar)             | El Release 1 respeta capacidad y <b>todas</b> las dependencias; la lista de verificación del analista se cumple.       | 1,5         |
| C6           | Reflexión técnica (Crear)                | Argumento fundamentado $\geq 120$ palabras, con terminología correcta de negociación de requisitos.                    | 0,5         |
| <b>TOTAL</b> |                                          |                                                                                                                        | <b>10,0</b> |

**Criterios transversales (descuentan en cualquier criterio):** usar el contexto de MediCita (no ejemplos genéricos); coherencia entre anexos; terminología técnica precisa; no dejar requisitos sin clasificar.

## Anexo D — Guía de facilitación y clave de referencia (uso del docente)

### Cómo facilitar la negociación

- Entregue **solo** la tarjeta correspondiente a cada estudiante; no comparta las otras.
- En la Fase 3, intervenga si la cliente intenta marcar todo como “Must”: recuérdelos la capacidad de 30 puntos.
- Refuerce el rol del **analista como mediador**: si está pasivo, pídale que proponga la votación ponderada.
- El conflicto central deseado: **no caben a la vez RF-03 (videollamada) y RF-04 (pago en línea)** dentro de 30 puntos. El equipo debe *elegir* y justificar.

### Conflictos esperados (clave de análisis)

| Conflicto                                                                                      | Tipo / causa                                           | Resolución win-win esperable                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Videollamada (RF-03) vs. pago en línea (RF-04): ambos de alto esfuerzo, no caben juntos.       | Conflicto de <b>intereses</b> (negocio vs. capacidad). | Elegir uno para R1 y diferir el otro a R2; o iniciar con cobro presencial y posponer el pago en línea. |
| Cliente quiere receta electrónica (RF-05); depende de NFR-01 y, para entrega real, de REST-01. | Conflicto <b>estructural</b> (dependencia).            | Diferir RF-05 hasta que REST-01 esté listo; mantener recetas en papel en R1.                           |
| Desarrollador quiere diferir cifrado; analista lo exige por normativa de datos de salud.       | Conflicto de <b>datos / conocimiento</b> .             | NFR-01 es Must si hay pagos o datos clínicos; no negociable.                                           |
| Cliente subestima usabilidad (NFR-02) para adultos mayores.                                    | Conflicto de <b>valoración</b> .                       | Acordar NFR-02 como Must: sin adopción no hay retorno.                                                 |

### Dos soluciones de referencia (ambas válidas)

No existe una única respuesta correcta; lo que se evalúa es el **razonamiento**, la **coherencia** y la **negociación**. Dos Release 1 defendibles, ambos  $\leq 30$  puntos:

**Solución A — “Lanzar con videollamada”** (suma Must = 29):

- **Must:** RF-01 (3), NFR-01 (5), NFR-02 (3), RF-08 (5), RF-02 (5), RF-03 (8) = **29 pts.**
- **Should:** RF-07 (3), RF-09 (3). **Could:** RF-06, RF-12. **Won’t:** RF-04, RF-05, RF-10, RF-11, NFR-03, NFR-04.
- *Lógica:* se prioriza el diferenciador frente al competidor (videollamada) y se cobra de forma presencial en R1; el pago con tarjeta llega en R2.

**Solución B — “Lanzar con pago en línea”** (suma Must = 29):

- **Must:** RF-01 (3), NFR-01 (5), NFR-02 (3), RF-08 (5), RF-02 (5), RF-04 (8) = **29 pts.**
- **Should:** RF-07 (3), RF-09 (3). **Could:** RF-06, RF-12. **Won’t:** RF-03, RF-05, RF-10, RF-11, NFR-03, NFR-04.
- *Lógica:* se prioriza monetizar desde el inicio (pago en línea con seguridad ya incluida); la videollamada se difiere a R2.

**Errores típicos a vigilar:** (1) marcar RF-02 como Must olvidando RF-08; (2) aceptar RF-04 sin NFR-01; (3) poner RF-05 como Must sin NFR-01 ni REST-01; (4) poner RF-11 como Must pese a que REST-01 no está; (5) exceder 30 puntos; (6) “ganar” por imposición en vez de win-win.

**Referencias:** Pohl, K. (2010). *Requirements Engineering: Fundamentals, Principles, and Techniques*. Springer. · IREB. *CPRE Foundation Level Syllabus*. · ISO/IEC/IEEE 29148:2018, *Systems and software engineering — Requirements engineering*. · DSDM Consortium, *MoSCoW Prioritisation*.

Integrante: Andrade José

Fecha: 3 de junio de 2026

Gilces José

Herrera Gilmar

#### C4. Reflexión final

En esta actividad se pudo destacar la estrategia de Negociación Colaborativa (Win - Win). Los involucrados tomamos el papel del Cliente, Analista y Desarrollador Líder. Gracias a la mediación del Analista se revelaron las informaciones asimétricas tales como las restricciones de capacidad, normativas legales y dependencias técnicas, que luego las usó como criterios objetivos para la toma de decisiones. Esto ayudó a balancear el valor de negocio con la viabilidad Técnica.

En caso hipotético de si la Dueña de la Clínica hubiera impuesto sus ideas y prioridades sin dar la oportunidad de negociar, el proyecto habría fallado en poco tiempo, esto a causa de un backlog lleno de Musts, una situación que era invariable ya que superaría los 30 puntos de capacidad, violando dependencias críticas como por ejemplo: Lanzar la función de reserva en Línea sin el panel del médico. También infringiría las normativas legales de protección de datos al omitir el cifrado básico.

La negociación evitó un producto defectuoso e incompleto debido a la complejidad técnica y su corto plazo de tiempo.